Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810520

Processo nº 0141939-91.2024.8.17.2001

AUTOR(A): H. C. F. L., DEBORA MARIA SILVA DE CARVALHO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência**, proposta por **H.C.F.L.**, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, **Debora Maria Silva de Carvalho**, devidamente qualificado (s) nos autos e representado (s), em face da **Bradesco Saúde S/A**, todos qualificados e representados.

Aduz que sua médica assistente, Dra. Patrícia Freire, de CRM 10711/PE a diagnosticou com déficit na produção do hormônio de crescimento (CID E23.0) e prescreveu uso diário e subcutâneo de GH, nomes comerciais Norditropin Flex Pro ou Genitropin, 0.9 mg/dia (0,031 mg/kg/dia), que tem como princípio ativo a Somatropina ou hormônio do crescimento, mas o plano de saúde réu negou a cobertura. Juntou negativa, outros documentos e recolheu custas.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja o plano de saúde réu compelido a custear e autorizar o tratamento solicitado pela médica da autora, com a reposição de hormônio de crescimento por prazo indeterminado, ou até pelo menos que a autora complete os 14 (catorze) anos de idade. No mérito requer a manutenção da tutela que pretende seja antecipada e a condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão em que indeferida liminarmente a tutela de urgência (Id. 191373788).

Oportunamente foi apresentada contestação (Id. 193989418) na qual sustenta, em sede de preliminar de mérito, carência da ação. No mérito, alega que não há previsão contratual para o tratamento e que ele não está previsto no Rol de Eventos em Saúde da ANS como de cobertura obrigatória.

Réplica (Id. 200802251).

Parecer do Ministério Público no Id. 205408071.

As partes não pugnaram pela produção de outras provas.

É o relatório, sucinto.
Passo a decidir.

Ressalto, de início, que o presente feito comporta julgamento antecipado, pois sendo a questão de mérito de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do

contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, acho-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto ao seu mérito, nos moldes do art. 355, I, segunda parte do Código de Processo Civil.

Em homenagem ao princípio da **primazia do julgamento de mérito**, deixo de apreciar a preliminar e prejudicial de mérito suscitada pela parte ré, em face da improcedência do pedido formulado pela parte autora, nos termos dos arts. 282, §2º, e 488, do Estatuto dos Ritos.

O cerne da questão posto em análise é decidir se tem a parte ré obrigação de dar cobertura a tratamento com hormônio do crescimento (medicamento de uso domiciliar) conformidade com as cláusulas contratuais, considerando-se, também, o conteúdo da Lei 9.656/98.

Pois bem, os pedidos são improcedentes.

Nas ações de plano de saúde, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Em assim sendo, da mesma maneira que os descumprimentos, por parte das operadoras de planos de saúde, das cláusulas contratuais desequilibram a avença originariamente pactuada impondo ônus excessivo a uma das partes, também o é a pretensão do segurado de obter benefício que não está previamente estipulado no contrato, e muito menos previsto em lei.

A consequência disso é a proliferação de demandas judiciais que poderia ser evitada pelo simples cumprimento contratual.

Ademais, para que o sistema privado de assistência à saúde seja mantido, é necessário que as obrigações de ambas as partes estejam claramente dispostas no contrato e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10º institui o plano-referência de assistência à saúde e estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

Pois bem, o inciso VI do art. 10 da referida lei prevê que as seguradoras não são obrigadas a fornecer medicamento para tratamentos no âmbito domiciliar, como é o caso dos autos, excetuando-se tal regra apenas nas hipóteses de tratamento de câncer, conforme disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12.

Considerando que a demandante é portadora de **baixa estatura, secundária a um déficit na produção do hormônio de crescimento (CID E23.0),** não sendo essa uma patologia do tipo câncer e que o **tratamento é em âmbito domiciliar,** não sendo de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde, a negativa não é abusiva. Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1996650 - PE (2022/0105337-7)EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. ***INEXISTÊNCIA****. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por RAFAEL ALBUQUERQUE MOTA DA SILVA (MENOR), com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição da República, em face de acórdão proferido pelo* ***TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO****, assim ementado (fl. 490): SEGURO SAÚDE. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (SOMATROPINA). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 10, VI E 12, I, 'c' e II, 'g' DA LEI Nº 9.656/98 E NO ROL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 428/2017 DA ANS, TAMPOUCO EM PARECERES TÉCNICOS SOBRE MEDICAMENTOS E/OU MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA COM BASE CONTRATUAL E NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.* ***Não configurada abusividade ou ilegalidade na conduta da seguradora apelada ao recusar a cobertura do custeio do medicamento SOMATROPINA, de uso domiciliar, fora do ambiente hospitalar e ambulatorial, para o qual não está obrigada por lei ou contrato, sendo***

legítima a conduta baseada em expressa exclusão contratual lastreada na excepcionalidade dos Arts. 10, VI e 12, I, 'c' e II, 'g' da Lei nº 9.656/98, bem como não fazendo parte do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017*, tampouco nas hipóteses de cobertura elencadas no PARECER TÉCNICO Nº 26/GEAS/ GGRAS/DIPRO/2018 e no recente PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre MEDICAMENTOS, assim como nos mais recentes PARECERES TÉCNICOS Nº 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre os MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. Conquanto o laudo da médica assistente ateste a necessidade do tratamento precoce com a reposição hormonal da somatropina até a idade óssea de 16 anos, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a excepcionalidade da pretensão, visando o tratamento melhorar a estatura do paciente à luz dos critérios da normalidade populacional e familiar. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 569-571). Em suas razões recursais (fls. 670-691), aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao artigo 1.022, inciso II e III, parágrafo único, inciso II, bem como ao artigo 489, § 1º, inciso IV, todos do CPC, pois o "acórdão Recorrido silenciou-se também no que tange o fato do art. 10, VI da Lei 9656/98 não vedar o fornecimento de fármacos, mas apenas possibilita que as operadoras de plano de saúde insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão." (fl. 680) Sustenta que o medicamento hormônio de crescimento (SOMATROPINA) se encontra previsto no Anexo I, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, que trata dos procedimentos de cobertura obrigatória pelos Planos de Saúde. Argumenta que nos termos do artigo 47, do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao segurado e que as disposições que coloquem o consumidor em exagerada desvantagem deve ser consideradas nulas, conforme dispõe o artigo 51 do CDC. Com apresentação de contrarrazões (fls. 733-741), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 742-744), ascendendo os autos a esta Corte. Parecer do Ministério Público Federal, manifestando-se pelo conhecimento parcial do recurso especial, e, nos pontos suscetíveis de conhecimento, quanto ao mérito, pelo seu não provimento (fls. 754-764). É o relatório. DECIDO. 2. No tocante à controvérsia acerca da negativa de cobertura ao tratamento com o medicamento destinado à doença que acomete a parte autora, objeto da ação, e à legitimidade de cláusula contratual que restringe o fornecimento de medicamentos não contemplados no ROL da Agência Reguladora - ANS, essa NÃO merece acolhida. Verifica-se que o Tribunal local considerou que não ficou demonstrada ser abusiva a cláusula contratual que previa suas restrições, conforme trecho abaixo transcrito, com grifos acrescentados (fls. 485-491): [...] Cinge-se a discussão travada no feito à obrigatoriedade ou não do custeio por parte da seguradora apelada do medicamento SOMATROPINA [Genotropin], na dose de 0,9mg/Kg/dia (Saizen 12mg, Genotropin 12mg, Norditropin 15mg ou Omnitrope 15mg). No caso em apreço, os recorrentes argumentam que a criança, à época com 07 (sete) anos de idade estaria na iminência de sofrer danos irreversíveis, ante a possibilidade de sofrer perda irreparável na sua altura final, motivo pelo qual deveria começar de imediato o tratamento prescrito para repor o hormônio do crescimento em seu organismo, conforme laudo médico acostado aos autos. Ocorre que a medicação pretendida se encontra nas situações de exclusão de cobertura insertas nos itens 15.10 e 15.12 das condições gerais pactuadas (Id. 7853281), referente a fornecimento de medicamento utilizado para tratamento em domicílio, ou seja, fora do atendimento ambulatorial ou regime de internação hospitalar. Ademais, de acordo com o Art. 10, VI da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, o medicamento prescrito não possui obrigatoriedade de cobertura pelo seguro de saúde contratado, por se tratar de medicação para tratamento domiciliar não inserido no rol de obrigatoriedade de cobertura previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do Art. 12 da norma em referência. Com efeito, conforme previsão inserta no caput do Art. 12 da Lei nº 9.656/98, devem ser respeitadas as amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o Art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: 1º) quando incluir atendimento ambulatorial, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (inciso I, alínea "c"); 2º) quando incluir internação hospitalar, a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (inciso II, alínea "g"). Assim, considerando que a medicação em tela não integra as hipóteses acima previstas, não estaria a operadora legalmente obrigada a fornecê-la. Note-se, ainda, que a Resolução Normativa nº 310, de 30 de outubro de 2012 da ANS, estabeleceu regras de adesão facultativa pelas administradoras, para a oferta de medicação de uso domiciliar para os seus beneficiários, mediante a elaboração de contrato acessório, com características diferenciadas em relação aos planos de saúde individuais e coletivos, também não se enquadrando o caso dos autos aos grupos das patologias ali descritas. Da mesma forma, a medicação questionada não se encontra nas hipóteses de cobertura elencadas no PARECER TÉCNICO Nº 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e no recente PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre MEDICAMENTOS, assim como nos mais recentes PARECERES TÉCNICOS Nº 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre os MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, não fazendo parte do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017.* ***De outra banda, ainda que o laudo (Id. 7853124)***

da médica que assiste o apelante ateste a necessidade do tratamento precoce com a reposição hormonal da somatropina até a idade óssea de 16 anos, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a pretensão, eis que de acordo com a referida declaração, o tratamento visa melhorar a estatura do paciente, por se encontrar no limite mínimo da normalidade populacional e bem abaixo do perfil familiar. Ora, considerando não haver previsão obrigatória no contrato firmado entre as partes, tampouco na legislação regedora dos planos e seguros privados de assistência à saúde, resoluções normativas e pareceres técnicos dos órgãos reguladores da matéria, nem razão suficiente a comprovar risco maior à saúde e/ou à vida do paciente, a ensejar a excepcionalidade do provimento jurisdicional, de modo a impor à operadora o fornecimento da medicação pretendida, tenho que carece ao pleito recursal elementos imprescindíveis ao seu acolhimento, não merecendo reparo o entendimento firmado no juízo de base. *[...] Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença combatida. É como voto. (grifou-se)* ***Do acima, se extrai que a conclusão a que chegou o Tribunal a quo está em conformidade com recentes precedentes unânimes das turmas de direito privado, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,*** *salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente*

nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). (grifou-se) Incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ. 3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (REsp n. 1.996.650, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/08/2022.)

E, embora não constatada nenhuma abusividade do plano de saúde réu no caso dos autos,não é demais trazer à baila o entendimento do intérprete da Lei Federal (no caso a Lei 9.656/1998) para situações como a dos autos:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROFISSIONAL APTO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MÉDICO. CIRURGIÃO DENTISTA. DÚVIDA FUNDADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 3. Hipótese em que a negativa em autorizar a realização de cirurgia buco-maxilo-facial decorreu de fundada dúvida sobre qual o profissional, médico ou dentista, estaria apto a prescrever e realizar o procedimento, tendo sido, ademais, afirmado na origem que não houve prejuízo ao tratamento realizado.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.569.212/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Isto posto, com base nos dispositivos legais antes mencionados, **julgo improcedentes** os pedidos formulados na inicial e extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no Art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e de verba honorária de 10% sob o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se. Preenchidos os requisitos legais**, arquivem-se.**

Recife, data da assinatura eletrônica.

Juiz de Direito no Exercício Cumulativo
34vcb1

Assinado eletronicamente por: CLAUDIO MALTA DE SA BARRETTO SAMPAIO
11/06/2025 14:43:43
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 206534543

25061114434370500000201142060

IMPRIMIR GERAR PDF